

Physioguide — Clínica — TFCC y dolor cubital de muñeca

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Fóvea, press, ulnar grind, piano-key; cluster B/C — elbow-wrist-tests-expansion.md

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

Dolor cubital de muñeca = síntoma, no diagnóstico. Puede deberse a TFCC (complejo fibrocartilaginoso triangular), DRUJ, ECU, intervalo LT, artrosis cubitocarpiana, fractura de estiloides cubital o cubital en Guyon. El TFCC estabiliza la DRUJ y amortigua carga ulnocarpiana. Lesión TFCC y DRUJ se solapan.

2. TYPICAL LOCATION

> «Señala el lado del meñique: ¿huequito, dorso, o tendón que se mueve al girar?»

- Sitio — Rama
 - Fóvea (hueco palmar-cubital) — TFCC foveal
 - Dorso cabeza cubital — DRUJ / piano-key
 - Tendón dorsal cubital al girar — ECU
 - Intervalo óseo dorsal cubital — LT
 - Tabaquera — Escafoides (otro módulo)
-

3. HISTORY

- Giro de antebrazo (destornillador, raqueta, caída con rotación)
 - Apoyarse para levantarse (press)
 - Desviación cubital repetida
 - FOOSH
 - Click cubital
 - Pregunta: «¿Duele el lado del meñique al girar la palma o al apoyarte?»
-

4. TRAUMA GATE

FOOSH + tabaquera != escafoides / RX antes de provocaciones agresivas.
Dolor cubital post-fractura de radio distal != DRUJ/TFCC secundarios.

5. CLUSTER TFCC

DOLOR CUBITAL FAMILIAR
+ FÓVEA POSITIVA
± PRESS TEST
± CARGA CUBITAL / GRIND
± DOLOR A PRONOSUPINACIÓN
!' TFCC COMPATIBILITY !'
+ PIANO-KEY ASIMÉTRICO DOLOROSO
!' AÑADE DRUJ

6. DIFFERENTIAL

- Entidad — Clave
 - ECU — Dolor tendinoso dorsal, peor en supinación contra resistencia
 - LT — Shear/ballotement, menos fóvea
 - Guyon — Parestesias cubitales palmares, a veces motor
 - Estiloides cubital — Trauma, dolor óseo puntual
 - Inestabilidad SL — Dolor central dorsal, Watson
-

7. AI RULES

- Nunca «TFCC confirmado» por fovea o grind.
- Nunca unificar todo dolor cubital como TFCC.
- Piano-key indoloro bilateral en laxo "" DRUJ patológica.
- Persistencia post-trauma !' imagen / mano-muñeca, no "esguince eterno".
- Citar Tay 2007 como serie de fovea; no extraer cifras universales.

Citation: Tay SC et al. *J Hand Surg Am.* 2007. Palmer classification (contexto). Adams DRUJ. Lester press test.

